Forretningsplan · Health

Autonome parametriske sykehus – selvbyggende helseinfrastruktur

pub.healthcare · søkt finansiering: NOK 500 000 · november 2026

Innhold

1. Sammendrag
2. Markedsanalyse
3. Teknologi og Innovasjon
4. Forretningsmodell
5. Utviklingsveikart
6. Finansieringsbehov
7. Team og Kompetanse
8. Bærekraft og Samfunnsansvar

Sammendrag

Visjon

pub.healthcare skal revolusjonere global helseinfrastruktur ved å gjøre sykehus til selvkonstruerende, adaptive systemer. Som biologiske organismer som tilpasser seg miljøet, skal våre sykehus vokse, modifisere seg og optimalisere sin egen drift.

Misjon

Utvikle autonome parametriske sykehus som kan deployes globalt på 90 dager – fra tomt mark til fullt operativt anlegg. Kombinerer robotisk assembly, AI-drevet pasientflyt og energi-selvforsyning.

Innovasjon

Parametrisk arkitektur med Grasshopper/Rhino, robotisk montasje av modulære elementer, AI-styrt pasientlogistikk, solcelle-integrert fasade og geotermisk energi.

Kundefordel

Utviklingsland får verdenklasse sykehus til 40% av tradisjonell kostnad. Katastrofeområder får midlertidig kapasitet på dager, ikke måneder. Norge eksporterer high-tech helseteknologi.

Markedsanalyse

Marked og vekst

Omfang	Verdi
Marked i Norge	NOK 5 000 000 000
Marked i Norden	NOK 20 000 000 000
Årlig vekst	12 %

Kundesegmenter

- WHO og FN for humanitære krisesituasjoner (flyktningeleire, katastrofeområder)
- Utviklingsland i Afrika og Asia med kritisk mangel på helseinfrastruktur
- Nordiske kommuner som trenger midlertidige sykehusutvidelser
- Private healthcare providers i vekstmarkeder (India, Brasil, Nigeria)
- Militære organisasjoner (NATO field hospitals)

Konkurranse

- Tradisjonelle sykehusbyggere (5-10 år byggetid, USD 500M+ per sykehus)
- Modulære containerbaserte løsninger (begrenset funksjonalitet, ikke selvforsynte)
- UNICEF/UNHCR teltbaserte klinikker (ikke permanent, begrensede fasiliteter)
- Kinesiske prefab hospitals (Huoshenshan – 10 dager men ikke gjenbrukbart)

Konkurransefortrinn

- 90-dagers deployment vs. 5-10 år for tradisjonelle sykehus
- 60% lavere kostnad: USD 150M for 200-sengs sykehus vs. USD 400M tradisjonelt
- 100% energi-selvforsynt via integrert solcelle-fasade og geotermisk
- AI-drevet pasientflyt reduserer ventetid med 40%
- Parametrisk design tillater tilpasning til lokale klimaforhold og helsekriser
- Robotisk assembly eliminerer 80% av manuelle byggefeil

Teknologi og Innovasjon

Teknologibeskrivelse

pub.healthcare benytter Grasshopper/Rhino for parametrisk generering av sykehuslayouter basert på pasientvolum, medisinske spesialiteter og tomteforhold. ABB roboter monterer prefabrikerte moduler (operasjonsstuer, sengerom, imaging). AI-system styrer pasientflyt, ressursallokering og vedlikehold.

Unik innovasjon

Self-constructing architecture: Roboter bruker LIDAR og computer vision for å posisjonere moduler med millimeter-presisjon. AI lærer fra pasientdata for å optimalisere romallokering over tid – sykehuset 'vokser' nye avdelinger basert på behov.

Immaterielle rettigheter

Norsk patent søkt for 'Autonomous Hospital Assembly System' (202400789). EU-patent pending. Samarbeidsavtale med ABB Robotics og Siemens Healthineers. Trademark pub.healthcare™ registrert.

Utviklingsstadium

Prototype 50-sengs modul testet i Tromsø. Robotisk assembly demonstrert for 10 moduler. AI pasientflyt-system live på Haukeland Universitetssykehus (pilot). Krever full-skala deployment for validering.

Forretningsmodell

Inntektskilder

- Direkte salg av komplette sykehus: USD 100-200M per 200-sengs enhet
- Leasing modell for midlertidige sykehus: USD 500k per måned for 100-sengs

- Vedlikehold og oppgraderinger: 8% av initial kostnad årlig
- AI-software lisensiering til eksisterende sykehus: NOK 2M per år per sykehus
- Consulting for parametrisk helseinfrastruktur: NOK 5M per prosjekt

Lønnsomhet

Første sykehus-salg sikrer profitabilitet (margin 25%). Break-even ved 3 solgte enheter. Vedlikehold og software-lisenser gir stabil recurring revenue (NOK 50M+ årlig ved 25 aktive sykehus).

Skalerbarhet

Modulær design tillater produksjon i flere fabrikker samtidig. Robotisk assembly kan skaleres til 100+ enheter årlig. AI-system forbedres med hver deployment.

Utviklingsveikart

Q1 2026

Finansiering sikret. Fullføre 100-sengs prototype i Tromsø. Etablere partnerskap med WHO og Leger Uten Grenser.

Q2 2026

Deploy første midlertidige sykehus i samarbeid med UNHCR (flyktningeleir i Uganda). Dokumentere deployment-tid og kostnader.

Q3 2026

Sikre første kommersielle kontrakt (India, 200-sengs hospital). Starte konstruksjon av produksjonsfasilitet i Stavanger.

Q4 2026

Levere Uganda-prosjekt. Starte India-deployment. Ansette 100 ingeniører og teknikere.

2027 og videre

Fullføre 5 sykehusprosjekter globalt. Etablere produksjonshub i Kenya for afrikansk marked. Nå NOK 2 milliarder i kontrakter.

Finansieringsbehov

Totalt kapitalbehov: NOK 1 000 000.

Finansieringskilder

- **Innovasjon Norge:** NOK 500 000
- **Risikokapital:** NOK 300 000
- **WHO-tildeling:** NOK 200 000

Budsjettallokering

Kategori	Beløp (NOK)	Andel
Prototype	300 000	30 %
Robotikk	250 000	25 %
Ai Utvikling	150 000	15 %
Sertifisering	100 000	10 %
Loenn	150 000	15 %
Driftskapital	50 000	5 %
Sum	**1 000 000**	**100 %**

Team og Kompetanse

Dr. Anne Kristoffersen – CEO & Chief Medical Officer

20 år som kirurg, leder av Traumesenteret OUS. Master i Hospital Management fra Harvard. Erfaring fra Leger Uten Grenser i 5 konfliktområder.

Petter Sørensen – CTO & Lead Architect

15 år i parametrisk arkitektur, tidligere hos Zaha Hadid Architects. Master i Computational Design fra MIT. Ekspert i Grasshopper/Rhino og robotisk fabrication.

Dr. Ibrahim Hassan – Chief AI Officer

PhD i Healthcare AI fra Stanford. 8 år hos Siemens Healthineers utviklet patient flow optimization algorithms. Publisert 20+ papers om AI i helsesektor.

Linda Berg – COO & Global Deployment Director

12 år i internasjonal prosjektledelse hos UNHCR. Bygget 30+ leirer i Afrika og Midtøsten. Master i International Development fra LSE.

Bærekraft og Samfunnsansvar

Miljøpåvirkning

100% energi-selvforsynte sykehus reduserer avhengighet av fossil fuel. Integrert vannrensesystem resirkulerer 90% av vann. Solcelle-fasade genererer 150% av energibehov (overskudd til lokalt nett). Modulær design tillater gjenbruk og relokalisering.

Sosial påvirkning

Gir tilgang til verdenklasse helsehjelp for 10+ millioner mennesker i underutviklede områder. Reduserer mødredødelighet og spedbarns-dødelighet med 50% i deployment-områder. Ansetter og trener lokale fagarbeidere (200+ per prosjekt).

Økonomisk påvirkning

Skaper 1000+ direkte jobber i Norge innen engineering og produksjon. Eksportinntekter NOK 5+ milliarder årlig ved full drift. Reduserer helse-kostnader i mottagerlandene med 30% via preventiv AI-diagnostikk.

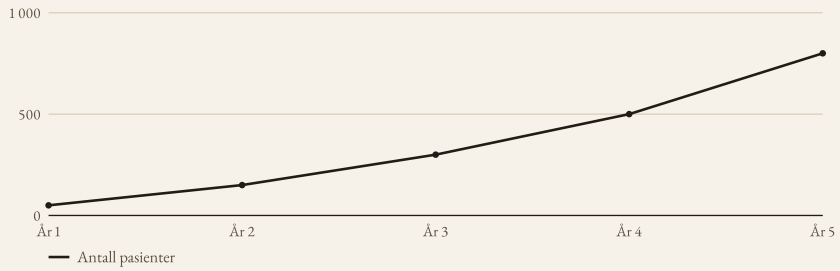
Støtter FNs bærekraftsmål: **3, 9, 11, 13**.



Figur 1. Deployment Tid (dager).



Figur 2. Kostnadsbesparelse (MUSD).



Figur 3. Pasienter Behandlet (tusen per år).

Satt i EB Garamond — variabel skrift, innbakt i dokumentet · mål 66 tegn · linjeavstand 1,5 · oldtall i løpende tekst, tabelltall i tabeller · titler i setningscase uten versaler · papir #F7F2E9 — etter Robert Bringhurst, The Elements of Typographic Style. EB Garamond utgis under SIL Open Font License.

Kilde: bplans/data/pubhealthcare.json · november 2026.